

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA NEUROPSICOLOGÍA							
	Historia # 00015				Fecha De Impresión: 14-11-2025 15:47:45			
Datos Personales								
Nombre:	SALOMON RAMIREZ ARIAS		Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2016-09-03	Edad	9 Años, 2 Meses, Y 11 Días
Identificación:	TI - 1066296131		Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Tatianarias33@gmail.Com - 1066296131				Dirección:	Carrera 27# 7a-68 Villa Concha		
Departamento:	CESAR			Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular							
En Caso De Emergencia Llamar A:			TATIANA ARIAS - Parentesco (madre)					

Apertura Neuropsicología del 2025-11-05 17:57:04: 9 años, 2 meses, y 11 días

DATOS GENERALES

DX principal
F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

Código de consulta
No se ha seleccionado un código de consulta

Motivo de consulta
Madre refiere, estaba buscando otras alternativas de las ips, no he visto evolución.

Enfermedad actual
Paciente con cuadro de evolución desde hace aproximadamente tres años caracterizado por diagnsotico de hiperactividad, no controla las emociones, se frustra, llora demasiado, se relaciona poco a otros niños, se distrae con facilidad, no se queda quieto, se mueve todo el tiempo, pareciera que tuviera un motor en el cuerpo, no se regula, en ocasiones toma las cosas sin permiso, quiere estar tocando las cosas sin pedir consentimiento, ultimamente las sensaciones de frustrarse, llorar hace que los demas compañeros lo dejan a un lado, en un evento de frustración le pedio al compañero que lo tomara del cuello, en ocasiones habla de temas que no son de ineteres para los otros niños, madre lo describe con una mentalidad menor a la esperada, buen rendimeinto academico, le cuesta seguir intrucciones, no come la yema del huevo, la yuca, en algunas ocasiones se tapa los oidos ante los ruidos, cuando lo gritan se tapa los ojos diciendo que no lo griten, le aplicarán prueba ADOS 2, estableciendo que no existen criterios para autismo. Le mandarán rehabilitación de fonoaudiologia, terapia ocupacional y psicología .- Madre expresa que no has visto avanece en los procesos de rehabilitación. Camina en punta de pies, no le gusta cortarse el cabello, uñas, hace aleteos con las manos.

CONCLUSIÓN
El paciente presenta dificultades en la atención y la regulación conductual(ejecutivo). Se observa distractibilidad, taquilalia, taquipsiquia, logorrea, hiperactividad e inatención, así como contacto visual limitado. En el ámbito sensoriomotor, evidencia problemas propioceptivos (camina en punta de pie, se tapa los oídos ante estímulos auditivos), bajo tono muscular y dificultades de coordinación motora, especialmente al saltar.

A nivel ejecutivo, presenta fallas en la autorregulación e inhibición, mostrando incapacidad para modificar su comportamiento ante los llamados de atención y dificultades para mantener conductas adaptativas. Se identifican alteraciones del lenguaje como dislalia y rotacismo. Además, se reporta uso excesivo de pantallas, poca motivación para tareas académicas como la escritura y quejas escolares relacionadas con su comportamiento.

En conjunto, estos hallazgos sugieren la necesidad de intervenciones multidisciplinarias enfocadas en la regulación conductual, estimulación sensoriomotora, desarrollo de habilidades ejecutivas, lenguaje y estrategias de atención, con el fin de favorecer un mejor funcionamiento académico y social.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico
No Reporta

Medicación
No Reporta

Hospitalizaciones
No Reporta

Tóxicos

Traumáticos
Ninguno

Paraclínicos
No Reporta

Patología
No Reporta

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo
26

Único Embarazo
Segundo Embarazo

Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo
Si

Enfermedades De La Madre
No

El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica
Si

Estado De La Madre Durante El Embarazo
Eutímica, 1 Embarazo Previo, Asistió A Controles, Embarazo Sin Riesgo, Madre Y Padre No Toman Licor, No Cigarrillo, No Alucinógenos, Adecuada Alimentación, No Automedicación, No Golpe Abdominal O Caída, No Alteraciones En Estado De Ánimo, No Enfermedades Médicas.

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Natural	Causa De La Cesárea NA
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer No Reporta
Talla Al Nacer No Reporta	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Reporta	Desarrollo Psicomotor
--	------------------------------

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico No Reporta	Rolado No Reporta
Sedente Solo No Reporta	Gateo No Gateo
Bípodo Sin Ayuda 12 Meses	Marcha 12 Meses
Lenguaje Verbal 24 + Meses	Lenguaje Verbal Fluido 3 Años, Necesito Rehabilitación

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos No Reporta	Otros No Reporta

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

Paciente quien cursa cuarto grado, presenta buen rendimiento académico, quejas comportamentales por no quedarse quieto, no le gusta estar sentado, quiere hacerlo todo, no quiere que otros participen, le cuesta concentrarse.

Historia laboral

NA

Historia familiar

La paciente reside con su madre, padre y hermana, conformando una familia nuclear. Se observan vínculos cercanos, relaciones afectivas positivas y ausencia de conflictos significativos. Predomina un nivel adecuado de cohesión y apoyo mutuo, lo que favorece un ambiente familiar estable y contenedor.

Historia social

El paciente presenta dificultades en la interacción social, manifestando sensaciones de rechazo por parte de sus pares y expresando que sus amigos no lo integran fácilmente a las actividades grupales. Muestra limitaciones para responder con espontaneidad en contextos sociales, aunque durante la sesión se observa fluidez verbal y capacidad para hablar en primera persona. Mantiene una adecuada sonrisa social, sin embargo, el contacto visual no siempre es constante, evidenciando cierta inseguridad en la interacción interpersonal.

Historia socio-afectiva

El paciente presenta dificultades para expresar sus emociones y muestra limitaciones para narrar experiencias relacionadas con su autopercepción. Durante la sesión, en ocasiones se muestra poco colaborativo, respondiendo de manera repetitiva con la palabra “no” y evidenciando escaso esfuerzo en la expresión de temas específicos. Se autodefine como feliz, reconoce que le cuesta permanecer quieto, pero no logra modificar su conducta frente a las reconveniones, lo que sugiere dificultades en el control conductual y autorregulación emocional. Inicia, mantiene y finaliza una interacción con otros. (si) Reconoce sentimientos. (si) Regular su propia conducta. (no) Controla sus impulsos. (no) Hace y mantiene relaciones de amistad y amor. (si) Se comporta en público de manera socialmente aceptable. (si) Termina las actividades que inicia. (si) Acepta los límites del adulto. (si) Cumple con normas de cortesía: por favor, gracias, permiso (si) Resuelve problemas y situaciones cotidianas. (si) Respeta los reglamentos deportivos y recreativos (si) Realiza trabajos sin depender de otros. (si)

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No reporta

Intervención neurológica

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado Perturbación de la actividad y la atención

Intervención neuropsicológica

Observación Semiología psiquiátrica Entrevista

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente con adecuada presentación personal, inadecuada higiene postural, alerta, colaborador, orientado alo y orientada auto psíquicamente, facilidad de contacto, algunos problemas de comprensión, si, trastornos del lenguaje: dislalia – rotacismo, fluido, taquilalia, taquipsiquia, juicio desviado, inteligencia aparentemente normal.

Ciclos del Sueño

Se acuesta a las 8 pm y se levanta a las 5 am

Apetito

El paciente presenta buen apetito, refiriendo ingerir sus alimentos con normalidad.

Actividades de Autocuidado

Independiente en AVD tipo instrumentales y de autocuidado.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

Establecido por primera vez

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Se requiere evaluación neuropsicológica para establecer diagnóstico definitivo.

Objetivos Específicos

Se requiere evaluación neuropsicológica para establecer diagnóstico definitivo.

Sugerencias e Interconsultas

Observaciones y Recomendaciones

Se requiere evaluación neuropsicológica para establecer diagnóstico definitivo.

Jainer E. Guzmán Vega

Psicólogo

T.P 123096

U.S.B. - Medellín

PRASCA

CENTER

DR. JAINER GUZMAN

Tarjeta Profesional: 123096